

光曝晒,以防破损、感染。治疗过程中若发生湿疹皮炎或大疱样改变,应立即停止敷贴,并保持局部卫生,对症处理。

做好每个患者的治疗档案登记,包括:姓名、性别、年龄、住址、联系方式、血管瘤的部位、种类、面积、治疗剂量、局部有无不良反应及疗效,并做好随访记录。治疗剂量应根据每个患者的实际情况制定个体化方案。每个患者治疗完毕后收回敷贴药片,杜绝丢弃,防止污染环境,严格执行放射性废弃物管理制度。

3 讨论

血管瘤是常见的良性软组织肿瘤,病理分型包括毛细血管瘤、幼年性毛细血管瘤、海绵状血管瘤、肉芽组织型血管瘤、静脉性血管瘤、微静脉性血管瘤、动静脉性血管瘤、上皮样血管瘤、弥漫性血管瘤、肌肉内血管瘤、后天性丛状血管瘤等多种类型^[1]。其中婴幼儿常见的主要为幼年性毛细血管瘤和海绵状血管瘤。其治疗方法较多,对于面积较小的幼年性毛细血管瘤可以采用激光、液氮冷冻^[3];面积较大者,放射性核素敷贴治疗是一种较好的选择^[2,4];而海绵状血管瘤可以采用手术切除、局部注射平阳霉素、放射性 P-32 胶体、埋置铜针、电化学等方法治疗^[2-7]。

放射性敷贴主要适应于幼年性毛细血管瘤。幼年性毛细血管瘤又称浅表性草莓状血管瘤、单纯性毛细血管瘤,是毛细血管瘤的不成熟型,主要见于婴儿,20%病例为多发型。病变早期与胎记相似,扁平、红色,哭闹或用劲时明显。随时间推移,病变隆起,称草莓痣。常在出生后几周内起病,几月内迅速增大、消退。消退时病变由鲜红色到暗红色、灰色。病变区皮肤皱曲。患者 7 岁时,75%~90% 病例消退,留下

一个色素瘢痕^[8]。因此该病被认为是一种自愈性疾病,但对于生长迅速的草莓状血管瘤,尤其是颜面部的血管瘤,还是应及时治疗,缩短病程。

放射性敷贴治疗,疗效肯定,不良反应轻,可以在婴幼儿熟睡时应用,患者依从性好。但是在治疗过程中,要严格遵守辐射治疗的必要性和合理性,对于病变面积较小、发展较慢的幼年性毛细血管瘤可以采取密切观察;对于生长迅速、位于颜面部的幼年性毛细血管瘤可以采取适当的放射性同位素的辐射治疗;在治疗过程中也应尽可能采用合适剂量的辐射和适形辐射,以减少病变部位可能出现的不良反应。

【参考文献】

- [1] 范钦和. 软组织病理学[M]. 江西:江西科学技术出版社, 2003:243.
- [2] 施常备,李竟成,许建林. 32P 治疗婴幼儿皮肤血管瘤 61 例[J]. 陕西医学杂志, 2005, 34(2):233-234.
- [3] 翁雪玲,叶敏莉,温作珍. 液氮冷冻治疗婴幼儿唇部血管瘤的护理[J]. 全科护理, 2009, 135(7):489.
- [4] 黄江河,唐真武. 90 镱敷贴改良法治疗血管瘤 248 例[J]. 实用医学杂志, 2009, 25(4):619-620.
- [5] 吴仕斌,喻爱喜,祝少博,等. 铜针留置栓塞治疗海绵状血管瘤的疗效观察[J]. 邵阳医学院学报, 2009, 28(1):67-68.
- [6] 郑江华,陈开. 平阳霉素治疗小儿体表血管瘤 1658 例临床分析[J]. 中国普外基础与临床杂志, 2009, 16(3):226-229.
- [7] 钟爱梅,顾东明,周宇丹,等. 小儿体表血管瘤的治疗及疗效分析[J]. 华中医学杂志, 2007, 31(3):187-188.
- [8] Bruckner AL, Frieden IJ. Infantile hemangiomas[J]. J Am Acad Dermatol, 2006, 55(4):671-682. (编校:何姝)

韧带样型纤维瘤病手术联合放疗疗效观察

李洪涛,戴丹菁,周遵艳,陶劲松,张文涛,喻世华,杨继元

Observe the Desmoid type fibromatosis of the efficacy of surgery combined with radiotherapy

LI Hong - tao, DAI Dan - jing, ZHOU Zun - yan, TAO Jin - song, ZHANG Wen - tao, YU Shi - hua, YANG Ji - yuan

Department of Oncology, Affiliated Tumor Hospital of Jingzhou, Jingzhou 434000, China.

【Abstract】 Objective: To observe of the efficacy of surgery combined with radiotherapy for Desmoid type fibromatosis. **Methods:** To analyze the data of 12 cases of Desmoid type fibromatosis. **Results:** Among 12 cases 8 located in one side of limbs, chest wall in 2 cases, 2 cases of abdominal wall. 10 cases were vimentin - positive, negative in 2 cases. In 3 - year postoperative follow - up, recurrence developed in 1 case, other 11 cases were disease - free survival. Diseasefree survival rate was 83. 33%. **Conclusion:** Surgery combined with radiotherapy may improve Desmoid type

【收稿日期】 2009 - 09 - 15

【修回日期】 2009 - 12 - 10

【作者单位】 湖北荆州市肿瘤医院肿瘤科,湖北 434000

【作者简介】 李洪涛(1971 -),男,湖北人,副主任医师,主要从事肿瘤放化疗工作。E - mail:hbsslt@126.com

【通讯作者】 杨继元(1963 -),男,湖北人,主任医师,主要从事肿瘤放化疗工作。

fibromatosis disease - free survival rate.

【Key words】desmoid type fibromatosis; surgery; radiotherapy

Modern Oncology 2010, 18(08): 1634 - 1636

【摘要】目的:观察韧带样纤维瘤病手术联合放疗的疗效。方法:总结我院收治的 12 例手术联合放疗韧带样纤维瘤病的 3 年无病生存率。结果:其中位于四肢 8 例,胸壁 2 例,腹壁 2 例。均行手术和术后放疗,手术病理证实为韧带样纤维瘤病,其中波形蛋白阳性 10 例,阴性 2 例。术后随访 3 年,1 例复发,其他 11 例均无病生存,无病生存率 83.33%。结论:手术联合放疗可提高韧带样纤维瘤病的无病生存率。

【关键词】韧带样纤维瘤病;手术;放疗

【中图分类号】R730.262; R730.55 【文献标识码】A DOI:10.3969/j.issn.1672-4992.2010.08.64

【文章编号】1672-4992-(2010)08-1634-03

韧带样型纤维瘤病(Desmoid type fibromatosis, DTFT)是一种罕见的软组织肿瘤,发生于深部软组织的纤维母细胞/肌纤维母细胞,也称为韧带样瘤、侵袭性纤维瘤病、肌腱膜纤维瘤病等。韧带样型纤维瘤病虽然表现为中间性肿瘤,但具有局部浸润性生长特性的 DTFT 的治疗方法是行广泛局部切除或根治性切除术,手术总治愈率近 90%。但由于 DTFT 的浸润性生物学行为,手术后易复发,其复发率文献报道不一,多在 20% - 70% 之间,甚至达 100%^[1-4]。我科在 2000 - 2006 年间采用手术加术后放疗的方式,治疗韧带样纤维瘤病,以期减少患者术后复发,现将具体情况报道如下。

1 资料与方法

一般资料本组男 4 例,女 8 例,平均年龄 38 岁,肿瘤位于四肢 8 例,胸壁 2 例,腹壁 2 例。所有患者都行手术治疗,手术病理证实为韧带样纤维瘤病,其中波形蛋白阳性 10 例,阴性 2 例,术后半月伤口愈合后行放疗,放疗在原瘤床区外放 5cm,用 X 线和电子线混合照射,用 X 线放疗 20Gy,电子线放疗 30Gy,放疗总剂量 50Gy。

2 结果

12 例韧带样型纤维瘤病患者行手术联合放疗治疗后随访 3 年,1 例复发。其他 11 例均无病生存。无病生存 83.33%,手术结合放疗联合韧带样型纤维瘤病可提高无病生存率。

3 讨论

3.1 发病特点

韧带样纤维瘤临床少见,本病呈散发性,部分有家族性聚集,发病率约 2 - 4/1000000,较为罕见,男女比例为 1:2 - 5,目前文献报道的各临床资料多为小样本病例报道,软组织肿瘤的 0.03%^[5],占纤维组织肿瘤的 1.19%^[6]。本病由 Muller1838 年命名为 Desmoid,即硬纤维瘤和腱样瘤,韧带样纤维瘤,临床表现为一生长缓慢的肿瘤,诊断主要依靠病理检查:显微镜下形态较一致的梭形细胞分布于大量增生的胶原纤维间质内,梭形的纤维母细胞和肌纤维母细胞常排列成束状,胞质界限不清,细胞异形性不明显。透射电镜下,纤维母细胞有丰富的粗面内质网和发达的高尔基复合体,肌纤维母细胞还可以看到应力纤维、纤维连接复合体、中间连接和缝隙连接。所有病例均表达波形蛋白,部分病例还表达结蛋白,和 $\alpha 2$ 平滑肌肌动蛋白其组织学特点为成纤维细胞和成肌纤维细胞交织成束,成纤维细胞常侵犯邻近正常结构,周围有大量胶原基质,内含大量细胞。肉膜巨细胞亦常见;无转移倾向,但局部侵袭性很强。

3.2 临床诊断

DTFT 临床上以无痛性肿块为主要症状,肿块生长缓慢,可以持续很长时间,以下几点可助临床诊断:①本病好发于女性,多见于 20 - 30 岁;②有妊娠生育,腹部手术或外伤史;③腹壁内肿块,尤其是下腹壁缓慢生长肿块,肿瘤质硬固定及多为圆形或类圆形;④肿瘤浸润性生长,局部切除术后易复发,复发率可高达 20% - 70%^[7-8];⑤B 超、CT、MRI 可确定肿瘤位置及浸润范围;⑥病理学检查为韧带样纤维瘤病。

3.3 治疗

大多数人认为完整的手术切除是唯一有效的治愈方法,但由于肿瘤常通过肌束及筋膜间隙的结缔组织向周围扩散侵犯,手术很难作准确判断,术后局部复发率高,有报道局部复发率高达 20% - 70%^[9],甚至达 100%。目前多数学者认为:手术切缘同术后复发明显相关,切缘阴性复发少,切缘阳性则复发高,主张将切缘阴性作为根治性切除的标准,切除标本后用肉眼观察肿块切缘,如发现灰白质硬的组织,说明未净应扩大切除范围,凡可疑者须作冰冻病理检查。息性切除患者的补救。报道药物治疗亦有效,但缺乏长期随访分析,曾用的化疗药物有阿霉素,放线菌素和长春新碱;另一类药物是环腺苷一磷酸盐(CAMP)、调节剂、非甾类抗炎药物(NSAID)和抗内分泌抑制剂。多数学者认为放疗对术后残留和术后复发的患者是有效的,放疗作为韧带样纤维瘤的非手术疗法,对提高局部控制率是很有帮助的,但是否常规行术后放疗还在探索中,本组病例行常规术后放疗,也是为了做这方面的研究,以期能为患者找到最佳治疗模式,目的是为了降低术后复发率,研究结果证明所有患者经随访三年,只一例复发,无病生存率 83.33%,单纯手术的复发率为 20% - 70%,经过对本组患者的疗效观察,手术加放疗的模式显著降低了患者术后复发率,使患者再次手术的风险大大降低,具有良好的临床效益。但因病例有限,其结果尚需进一步做大样本观察。

【参考文献】

- [1] Goldblum J, Fletcher JA. Desmoid type fibromatosis [A]. Fletcher CDM, Unnikk, Mertensf. World health organization classification of tumors: pathology and genetics of tumor of soft tissue and bone [M]. Lyon IARC Press, 2002. 83 - 84.
- [2] Reitamo JJ, Hayry P, Nykyri E, et al. The desmoid tumour. Incidence, sex, age and anatomical distribution in the Finnish population [J]. Am J Clin Pathol, 1982, 77(6): 665 - 673.
- [3] Lucas DR, Abbadi M, Tabaczka P, et al. Kit expression in desmoids fibromatosis. comparative immunohistochemical evaluation of two commercial antibodies [J]. Am J Clin Pathol, 2003, 119(3): 339 - 345.

- [4] Ballomt, Zagarsgk, Pollacka, et al. Desmoid tumor: prognostic factors and outcome after surgery, radiation therapy, or combined surgery and radiation therapy[J]. J Clin Oncol, 1999, 17(1): 158 - 167.
- [5] Rodriguez Bigas MA, Mahoney MC, Karakousi CP, et al. Desmoid tumors in patients with familial adenomatous polyposis[J]. Cancer, 1994, 74(4): 1270.
- [6] Easter DW, Halasz NA. Recent trends in the management of desmoid tumors[J]. Ann Surg, 1989, 210(6): 765 - 768.
- [7] Dahn I, Jonsson N, Lundn G. Desmoid tumors: A series of 33 cases[J]. Acat Chif Scand, 1963, 126: 305 - 314.
- [8] Khorsand J, Karakousi CP. Desmoid tumors and their management[J]. Am J Surg, 1985, 149(2): 215 - 218.
- [9] Leithner A, Gapp M, Leithner K, et al. Margins in extra - abdominal desmoid tumors: a comparative analysis[J]. J Surg Oncol, 2004, 86(3): 152 - 156.

(编校:何姝)

流行病学

中山市 2005 年恶性肿瘤发病流行状况

任小青, 魏矿荣, 梁智恒

【摘要】 目的:探讨中山市 2005 年恶性肿瘤发病流行规律,为中山市恶性肿瘤防治提供科学依据。**方法:**收集中山市 2005 年肿瘤登记处恶性肿瘤发病资料,分析其发病数、初发病率、中国与世界标化发病率等指标。**结果:**中山市 2005 年恶性肿瘤世界标化发病率男性为 252.80/10 万,女性为 150.16/10 万,男女发病前 5 位恶性肿瘤是肺、肝、鼻咽、食管、胃、结/直肠、乳腺与子宫体等恶性肿瘤。**结论:**中山市 2005 年恶性肿瘤发病虽然为全国低中水平,但发病有上升趋势,尤其在某些城镇较为突出,可能与该地区工业发展、环境改变或人口老龄化相关。

【关键词】恶性肿瘤;发病率;流行病学

【中图分类号】R73 - 31

【文献标识码】A

DOI:10.3969/j.issn.1672-4992.2010.08.65

【文章编号】1672-4992-(2010)08-1636-02

本文对中山市 2005 年恶性肿瘤发病流行状况进行分析研究,了解我市城乡居民恶性肿瘤发病、死亡、生存状况、流行特征、趋势和疾病负担,为指定肿瘤防治策略和措施提供基础信息和客观依据。

1 材料与方法

1.1 肿瘤资料来源

恶性肿瘤发病资料来源于中山市肿瘤研究所肿瘤登记处。资料按国际疾病分类第十版(ICD-10)进行编码和分类,然后统计分析。

1.2 人口资料来源

人口资料来源于中山市统计局。中山市 2005 年人口资料年龄构成根据 2000 年全国人口普查时中山市人口年龄构成推算而得。

1.3 统计方法与统计指标

由 EXCEL 软件建立数据库并进行统计分析。统计指标有发病数、初发病率、中国标化发病率、世界标化发病率和发病构成比等。统计方法采用全国肿瘤防治研究办公室推荐的使用方法,中国与世界标准人口分别以 1982 年中国人口构成与 2000 年世界人口构成作为标准^[1]。

2 结果

2.1 发病概况

中山市 2005 年恶性肿瘤初发病共 2913 例,其中男性 1756 例,女性 1157 例,男女发病比例为 1.52:1,见表 1。

中山市 2005 年恶性肿瘤初发患者病理细胞学诊断率(M/V%)为 72.1%。恶性肿瘤死亡发病比(M/I)男性为 0.79,女性为 0.60,合计为 0.72。

表 1 中山市 2005 年恶性肿瘤发病概况(n,1/10 万)

性别	例数	初发病率	中国标化发病率	世界标化发病率
男	1756	250.07	196.17	252.80
女	1157	165.50	121.16	150.16
合计	2913	207.88	156.49	198.06

2.2 发病顺位

2005 年中山市发病前 10 位恶性肿瘤,男性依次是肺、肝、鼻咽、食管、胃、结肠、直肠、膀胱、喉与前列腺等部位;女性依次是乳腺、肺、子宫体、鼻咽、结肠、肝、子宫颈、直肠、胃与脑等部位。男女鼻咽恶性肿瘤占中山市同期恶性肿瘤发病顺位的第 3、4 位(表 2)。

2005 年中山市女性食管恶性肿瘤死亡发病比(M/I)为 1.38,其余恶性肿瘤死亡发病比(M/I)均小于 1。

2.3 年龄发病率

2005 年中山市恶性肿瘤发病从 35 岁左右开始迅速上升,55 岁左右达高峰,其后逐渐下降,发病年龄主要集中在 40-79 岁年龄段。40-79 岁发病的男性占中山市同期男性恶性肿瘤总数的 83.2%,女性占中山市同期女性恶性肿瘤总数的 76.2%(见图 1)。

2.4 地域发病概况

【收稿日期】 2010-01-08

【作者单位】 广东省中山市肿瘤研究所,广东 中山 528403

【作者简介】 任小青(1955-),女,北京人,副主任医师,主要从事恶性肿瘤临床流行病学研究。